PRIPREMA ZA ISPIT · SKRIPTA

Organizacija zdravstva: suština za ispit

Najbitnije iz pet lekcija sa prezentacija i dve lekcije iz video predavanja, sa tabelom brojki i rokova na kraju.

Kako učiti iz skripte

Skripta sadrži suštinu pet lekcija sa prezentacija, istim redom kao na predmetu, i dve lekcije iz video predavanja (6 i 7). Izbačeni su uvodni slajdovi, ilustracije i ponavljanja; ostalo je ono što se realno pita.

1. Pročitaj jednu lekciju i odmah uradi njene testove.
2. Pitanja na kojima pogrešiš vrati u skriptu i podvuci.
3. Poslednji odeljak, „Brojke i rokovi", ponovi dan pred ispit: tu se najlakše gube poeni.
4. Na kraju uradi simulaciju ispita (30 pitanja, 30 minuta).

Lekcija 1: Organizacija zdravstvene delatnosti, uvod

Predavač: dr med. Miloš Potkrajac. Lekcija objašnjava šta je sistem zdravstvene zaštite, od čega se sastoji, kako je uređen u Srbiji i kako se finansira.

Regulativa

- **Zakon o zdravstvenoj zaštiti**: osnovni zakon.
- **Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti** u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe: uređuje uslove za rad ustanova.
- **Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga**: odnosi se na primarni nivo.
- **Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima** i **Zakon o zdravstvenom osiguranju**.

Zdravstvena zaštita

- **Definicija:** organizovana i sveobuhvatna delatnost društva.
- **Osnovni cilj:** najviši mogući nivo očuvanja zdravlja građana i porodice.
- **Obuhvata mere za:** očuvanje i unapređenje zdravlja; sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja; blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Sistem i sistem zdravstvene zaštite

- **Sistem:** skup međusobno povezanih elemenata koji zajedno dovode do dostizanja ciljeva u sredini u kojoj sistem egzistira.
- **Podsistem:** svaki posmatrani sistem je deo većeg, složenog sistema (sistema višeg reda) i u njemu ima status podsistema.
- **Veliki društveni sistem** ima podsisteme: politički, privredni (industrija, poljoprivreda, trgovina), sistem socijalne zaštite, sistem zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna, tercijarna) i sistem obrazovanja (osnovno, srednjoškolsko, visoko).
- **SZO definicija:** sistem zdravstvene zaštite obuhvata zdravstvenu infrastrukturu koja obezbeđuje spektar programa i usluga i pruža zaštitu pojedincima, porodicama i zajednici.

- **Svrha:** očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi obezbeđivanjem usluga moderne i tradicionalne medicine, na efikasan način, dostupnih i prihvatljivih ljudima.
- **Sistemi su:** pod jakim uticajem normi i vrednosti društva; odraz socijalnih i kulturalnih očekivanja građana; pod uticajem nacionalne istorije, tradicije i političkog sistema.

Pet komponenti sistema zdravstvene zaštite

1. Resursi
2. Organizacija i administriranje
3. Menadžment
4. Finansiranje
5. Obezbeđivanje i pružanje zdravstvene zaštite

Shema komponenti: u središtu je participacija zajednice. Krug teče ovako: zdravstveni problemi → ulaganja u službu → distribucija ulaganja → rezultati rada službe → ishodi po zdravlje ljudi. Oko svega su menadžment i organizacija i sistemi podrške, a spolja uticaji: socijalni, kulturalni, sredinski, politički, ekonomski, ekosistemski.

Resursi i kadrovi

GRUPA RESURSA	ŠTA OBUHVATA
Ljudski resursi (kadrovi)	lekari, stomatolozi, farmaceuti; medicinske sestre i tehničari; saradnici
Ustanove	zgrade, oprema
Sredstva	lekovi, sanitetski materijal

- **Važni aspekti kadrova:** odgovarajuće obrazovanje i obuka; obezbeđenost stanovništva zdravstvenim radnicima (pokazatelj: broj stanovnika na 1 lekara).
- **Ključno pitanje svih zemalja:** koliko lekara, sestara i saradnika obrazovati i obučavati.

Organizacija i administriranje

- Formulisanje zdravstvene politike.
- Planiranje i uspostavljanje prioriteta za dostizanje ciljeva.
- Postizanje „vrednosti za novac" (efektivnost, efikasnost; zdravstvena zaštita zasnovana na dokazima).

Nivoi zdravstvene zaštite (piramida)

NIVO ZAŠTITE	VELIČINA POPULACIJE	ADMINISTRATIVNI NIVO
Subspecijalistička	500.000 – 5.000.000	region
Specijalistička	100.000 – 500.000	okrug
Opšta medicina	2.000 – 50.000	lokalna zajednica, opština
Samozaštita	1 – 10	pojedinac / porodica

Zdravstveni sistem Srbije

Na vrhu je **Ministarstvo zdravlja**, a ispod njega pet celina:

CELINA	SASTAV
Agencija za lekove i medicinska sredstva	Nacionalna kontrolna laboratorija; Nacionalni centar za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima; Centar za humane lekove; Veterinarski sektor; Sektor za medicinska sredstva; Centar za podršku
Komore (5)	Farmaceutska; Komora biohemičara; Lekarska; Stomatološka; Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara
Zdravstvene ustanove	primarni, sekundarni i tercijarni nivo; na više nivoa
Institut za javno zdravlje Srbije	instituti za javno zdravlje; zavodi za javno zdravlje
Republički fond za zdravstveno osiguranje	pokrajinski fond; filijale fonda; ispostave filijala

- **Vertikalan odnos:** između različitih nivoa (Ministarstvo zdravlja → dom zdravlja).
- **Horizontalan odnos:** između ustanova istog nivoa (Zavod za javno zdravlje Kruševac ↔ Zavod za javno zdravlje Sombor).

Devet oblika zdravstvene ustanove

Dom zdravlja; apoteka; bolnica (opšta i specijalna); zavod; zavod za javno zdravlje; klinika; institut; kliničko-bolnički centar; klinički centar.

Finansiranje

IZVOR	POJAŠNJENJE
Državni budžet	opšti i specifični porezi
Fond osiguranja	obavezno zdravstveno osiguranje (doprinosi); dobrovoljno/privatno osiguranje (premije)
Plaćanje iz džepa	participacija (lično učešće u troškovima); puna cena usluge (privatna praksa)
Donacije	dobrovoljni prilozi

Modeli sistema zdravstvene zaštite

„Svi sistemi zdravstvene zaštite su nesavršeni i skupi."

MODEL	NAZIV
Nacionalna zdravstvena služba (NHS)	Beveridžov model
Obavezno zdravstveno (socijalno) osiguranje	Bizmarkov model

MODEL	NAZIV
Privatno osiguranje	model nezavisnog korisnika, „divlji zapad"

Lekcija 2: Komunikacija u delatnosti zdravstvenih radnika

Predavač: Zlatko Ćirić. Lekcija ima četiri celine: pojam i oblici komunikacije, grupe i timovi, komunikacija sa pacijentom i teški sagovornici.

Pojam komunikacije

- **Definicija:** dinamičan i stalno promenljiv proces u kojem ljudi šalju verbalne i neverbalne poruke s ciljem da ih drugi razumeju, da oni razumeju druge, da se prilagode ostalima i prenesu svoje ideje.
- **Druga definicija (poster):** proces razmene informacija preko dogovorenog sistema znakova. **Komunikologija** je naučna disciplina koja proučava komuniciranje.
- **SZO:** kvalitetna komunikacija je jedna od **pet** veština neophodnih za zdrav i srećan život.
- **Formalne komunikacije:** prenose se unapred utvrđenim kanalima (pravila, standardi, propisi).
- **Neformalne komunikacije:** teku van zvaničnih, formalnih kanala.
- **Komuniciranje u zdravstvu je formalni tip.** Interna komunikacija lekara i sestara određena je organizacionom šemom i hijerarhijskom strukturom.
- **Odnos zdravstveni radnik–pacijent** je suština procesa pomoći.
- Komuniciranje u zdravstvu zahteva znanje, kompetenciju i tehničke veštine, pa je potrebno permanentno učenje i vežbanje svih članova tima.

Komunikacioni proces: pet elemenata

1. **Pošiljalac poruke:** osoba koja ima misao, ideju ili emociju koju želi da prosledi.
2. **Poruka:** misao, ideja ili emocija koju jedna osoba šalje drugoj.
3. **Metod slanja:** verbalna, neverbalna, kombinovana.
4. **Primalac poruke:** prima i tumači poruku.
5. **Povratna sprega (feedback):** odgovor koji pošiljalac dobija od primaoca.

Uspešna komunikacija: primalac shvata šta pošiljalac poručuje. Ne mora dovesti do saglasnosti, ali mora biti stvarna razmena mišljenja. Najefikasnija komunikacija je jasna i direktna.

Oblici komunikacije

Osnovna podela: verbalna, neverbalna, interpersonalna, grupna, javna, masovna.

OBLIK	SUŠTINA
Verbalna	Oblik na koji prvo pomislimo; ključ razumevanja u zdravstvenoj nezi. Sastoji se od glasa, poruke, načina prenošenja i odgovora. Glas prenosi emocije, ton daje sigurnost; važni su izbor reči i brzina govora. Neki elementi su urođeni, većina se uči.
Neverbalna	Pretežno spontana, ali i namerna. Osnovna uloga: traženje, uspostavljanje, održavanje, usmeravanje ili prekidanje socijalne interakcije.
Interpersonalna	Između najmanje dve osobe, licem u lice; šalju se simboli (verbalni i neverbalni). Svrha: upoznavanje ljudi i sveta oko sebe i slika koju drugi stiču o nama. Najvažniji cilj: uspostavljanje stabilnih međuljudskih odnosa.

OBLIK	SUŠTINA
Grupna	Članovi grupe su povezani, razmenjuju ideje i rešavaju zajedničke probleme.

- **Elementi neverbalne komunikacije:** gestovi, pokreti u prostoru, držanje tela, izraz lica, pogled, ritam i tonalitet govora, boja glasa, odevanje.
- **Poboljšanje komunikacije:** posmatranjem, obraćanjem pažnje, odgovaranjem na zahteve i proveravanjem informacija.
- **Oblici komuniciranja sa postera (7):** interpersonalna, intrapersonalna, govorna, neverbalna, aktivno slušanje, telekomunikacija, računarski posredovana.

Šest osobina (slajd „Poboljšanje komunikacije"):

OSOBINA	ZNAČENJE
Istinitost	iskrenost prema nečijim osećanjima
Prihvatanje osećanja	ko prihvati svoja osećanja, može prihvatiti i druge kakvi jesu
Otvaranje	sposobnost da se podele osećanja
Razumevanje	prihvatanje postupaka drugih, uz osećaj za njihove težnje i potrebe
Briga	želja da se pomogne drugima, individualno i društveno
Humor	sposobnost da se napravi šala na svoj račun

Grupe i uloge

- **Grupa:** zajednica više ljudi koji čine celinu na osnovu zajedničkih ciljeva i interesovanja. U malim grupama komunikacija je licem u lice i svaki pojedinac dolazi do izražaja.
- **Četiri vrste uloga:** profesionalne (nameće ih profesija), starosne (zavise od životne dobi), polne (ponašanje prema istom ili suprotnom polu), klasne i statusne (zavise od društvenog statusa).
- **Tri vrste grupa po funkciji:** porodične (osnovna ljudska grupa, tu se uči prvo komuniciranje); neformalne prijateljske (slobodna, lična komunikacija); formalne organizovane (školske grupe, profesionalne i sportske organizacije, klubovi, crkvena udruženja, političke partije).
- **Osobine medicinske sestre/tehničara za uspešnu komunikaciju i dobre odnose u timu:** otvorenost, srdačnost, samopouzdanje, empatija, aktivno slušanje, izbegavanje stereotipa i predrasuda, asertivnost.

Tim

- **Tim:** određeni broj pojedinaca sa zajedničkim ciljevima i interesima. Formira se sa jednim glavnim ciljem: da se poslovi uspešnije obave. Timski rad poboljšava komunikaciju i sposobnosti i pojedinca i organizacije.
- „Biti deo tima nije svojstveno ljudskoj prirodi, to se uči" (Crosby).
- **Osnovne karakteristike timova:** vremensko trajanje (stalni: menadžment i radni timovi; privremeni: projektni timovi), međusobna promenljivost, obim zadataka i funkcija.
- **U reanimaciji i radu sa kritično obolelima** komunikacija tima je delikatna i specifična.

FAZA RAZVOJA TIMA	ŠTA SE DEŠAVA
Formiranje	određuje se šta bi članovi trebalo da rade
Iskazivanje	članovi iznose stavove u kojima ima nesigurnosti i nesuglasica
Normiranje	želja da se započne organizacija među članovima
Funkcionisanje	razvijena lojalnost grupi, otvorenost i uzajamno poverenje

- **Opšte karakteristike tima:** ima svoj identitet; ima jedan primarni cilj; struktura je fleksibilna; vođa određuje odgovornosti i aktivnosti; nagrađivanje je spoljašnje i unutrašnje; odnose karakteriše saradljivost; međuzavisnost članova znači opstanak i uspešnost; članovi moraju imati odgovarajuće sposobnosti i umeća; karakteristike tima određuje širi organizacioni sistem.
- **Prednosti timskog rada (3):** više specifičnih znanja; međusobna stimulacija i motivisanje; zadovoljenje društvenih potreba članova.
- **Timske uloge (Belbin, 1993), 9:** koordinator, onaj koji oblikuje, kreativac, istraživač resursa, implementator, timski radnik, izvršilac, osoba koja nadgleda i procenjuje, stručnjak.
- **Uspešan tim (7):** otvorena komunikacija, poverenje, uzajamna podrška, dobro vođstvo, odgovarajuće sposobnosti članova, upravljanje ljudskim različitostima, selektivno korišćenje tima.
- **Prepreke efikasnosti (8):** nedostatak osećaja direkcije, slabo vođstvo, rivalitet, pogrešno usmerena energija, izbegavanje odgovornosti, nedostatak poverenja, nedostatak veština, nedostatak spoljašnje podrške.
- **Mogući uzroci neefikasnosti tima:** lični problemi; nesnalaženje sa novim strukturama ili tehnologijama; razočarenje zbog izostanka priznanja ili nagrade; razlaz sa članom tima; loša komunikacija s novim članovima; prezasićenost i monotonost posla; gubitak statusa.
- **Ključ za formiranje uspešnih timova:** jasni ciljevi; hrabriti tim da ide za malim pobedama; građenje poverenja; međusobna odgovornost i osećaj zajedničke svrhe; eksterna podrška; treninzi; promena članova tima.
- **Cilj komunikacije u timu:** sprečiti negativnu komunikaciju i izbeći dvosmislena pravila; jasno podeliti zadatke; usavršiti neverbalnu komunikaciju (veoma bitna u urgentnim stanjima); komunikacija mora biti dvosmerna, uz poštovanje svih članova.

Komunikacija u zdravstvenoj delatnosti

- Najsloženija je i najosetljivija, a uspeh je neizvestan.
- **Situacije u kojima komuniciramo:** usmeno i neposredno; telefonom; na terenu i u domu pacijenta; pisanim putem.
- **Žalbe korisnika:** komunikacija sa zdravstvenim radnicima je daleko najveći izvor žalbi. Odnose se na neposvećivanje pažnje i vremena, saopštavanje dijagnoze bez empatije, stručnu terminologiju, izostanak privatnosti i nečuvanje profesionalne tajne.

BARIJERA	U ČEMU JE PROBLEM
Organizacija poruke	suviše razgranata (opširna, neprecizna); uopštena i nerazumljiva; bez jasne misli
Reči poruke	dvosmislenost; suvišne, nevažne reči

BARIJERA	U ČEMU JE PROBLEM
Ljudi (smetnje u kanalu)	sklop ličnosti; potrebe, motivi i emocije učesnika

- **Zašto je dobra komunikacija važna:** većina neuspešnog timskog rada povezana je s narušenom komunikacijom; više od **60%** neželjenih događaja posledica je loše komunikacije (JCAHO, 2004).
- **Dobar razgovor je ključan za:** dobru negu pacijenta; pravilno funkcionisanje tima; odnose zasnovane na poverenju; izrastanje u vođu.
- **Udeo u poruci:** govor tela 55%, način na koji kažemo 38%, ono što kažemo 7%.
- **Govor tela:** širok spektar nesvesnih pokreta koji mogu da poboljšaju ili naruše komunikaciju; komuniciramo i kad mirno sedimo.

Zdravstveni radnik i pacijent

- Komunikacija je bitan i sastavni deo terapijskog postupka.
- Zdravstveni radnik vodi računa o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, svestan je važnosti svojih reči i ponašanja i **komplementaran je, a ne rivalizujući**.
- Razgovor mora biti **dvosmerni dijalog, a ne jednosmerni monolog**.
- Poruka pacijentu treba da bude jasna, glasna i precizna; komunikacija je „dvosmerna ulica".
- Kvalitetnom komunikacijom pacijent postaje aktivni saradnik u rešavanju zajedničkog problema koji se zove bolest.
- Komunikacija se, kao i svaka veština, usavršava vežbanjem i traži stalnu negu.

Osobe sa teškoćama u komunikaciji

Takve osobe skreću tok komunikacije i udaljavaju se od sadržaja da bi zadovoljile svoje potrebe. Zdravstveni radnik treba da prepozna tip ličnosti, da probleme ne shvata lično i da uspostavi uljudan odnos usmeren na argumente, činjenice i podatke.

TIP OSOBE	KAKO SE PONAŠA	STRATEGIJA
Agresivna	kritikuje, omalovažava, povređuje druge, napeta, nestrpljiva	pažljivo slušanje, smirenost, argumentovanost, racionalnost, činjenice, čvrst stav
Depresivna	bezvoljna, potištena, odsutna duhom, usporena	interesovanje, strpljenje, tolerancija, vedrina, ohrabrenje
Egocentrična	arogantna, teatralna, traži uvažavanje, „filtrira" informacije, ističe svoje potrebe	ne kritikovati, odati priznanje, uvažavati „posebnost", usmeravati ka konkretnim ciljevima bez konfrontacije
Paranoidna	nepoverljiva, sumnjičava, oprezna, stalno proverava, sklona optužbama	izbeći uvlačenje u „sistem", pozivati se na činjenice, biti neutralan
Anksiozna	uznemirena, nesigurna, neodlučna, ne toleriše nejasnost	dobronamernost, smirivanje, zainteresovanost; izbeći da anksioznost pređe u ljutnju i prekid

- **Opšte smernice:** nikada ne aktivirati negativne potencijale osobe; ponekad joj izaći u susret radi beskonfliktne komunikacije; držati se teme.

- **Boljom komunikacijom dobijamo:** zdrav i uspešan tim; zadovoljstvo zaposlenih; bolje upravljanje vremenom; veću produktivnost i efektivnost; podršku i poverenje. **Moć sa ljudima, a ne nad ljudima.**

Lekcija 3: Menadžment i organizacija zdravstvene službe

Predavač: Zlatko Ćirić. Lekcija ide od opštih pojmova (sistem, menadžment, zdravlje) do toga kako je svaka vrsta ustanove organizovana iznutra.

Osnovni pojmovi

- **Zdravstveni sistem:** sve organizacije, institucije i resursi posvećeni preduzimanju zdravstvenih akcija.
- **Zdravstvena akcija:** bilo koji napor (u ličnoj zdravstvenoj zaštiti, društvenoj zdravstvenoj službi ili kroz međusektorske inicijative) čija je primarna namera da poboljša zdravlje.
- **Zdravlje (SZO, Svetska zdravstvena skupština 1948, sadržano u Ustavu SZO):** stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili telesnih nedostataka (invalidnosti).

KOMPONENTA ZDRAVSTVENOG SISTEMA	NA ŠTA SE ODNOSI
1. Razvoj zdravstvenih resursa	kadar, zdravstveni kapaciteti, oprema i snabdevanje, znanje
2. Organizovano uređenje resursa	nacionalne zdravstvene vlasti, zdravstveno osiguranje, državne i nevladine agencije, nezavisni privatni sektor
3. Pružanje zdravstvene zaštite	nivoi: primarni, sekundarni, tercijarni
4. Ekonomska pomoć	državni izvori finansiranja, vlasnici, organizacije, volonterske agencije, lokalne zajednice, inostranstvo, privatna domaćinstva
5. Menadžment	vođstvo, odlučivanje, regulacija

- **Tri cilja zdravstvenog sistema:** unapređenje i očuvanje zdravlja ljudi; odgovor na očekivanja i zahteve ljudi; poštena (pravedna, fer) kontribucija, odnosno doprinos ljudi.
- **Četiri funkcije menadžmenta:** planiranje, organizovanje, vođenje, kontrola.
- **Tri grupe uloga menadžera:** izgradnja međuljudskih odnosa, informisanje, donošenje odluka.

Ustanove i drugi oblici

- **Vrste zdravstvenih ustanova:** dom zdravlja, bolnica, apoteka, zavod, zavod za zaštitu zdravlja, klinika, institut, apotekarska ustanova, zdravstveni centar, kliničko-bolnički centar, klinički centar.
- **Drugi oblici zdravstvene delatnosti:** lekarska ili stomatološka ordinacija, dispanzer, zdravstveni kabinet, zdravstvena stanica, zdravstveno savetovalište, apoteka, laboratorija, patronažna služba, poliklinika, služba kućnog lečenja i zdravstvene nege, ambulanta, medicinska sestra ili tehničar za medicinsku negu.
- **Izvori sredstava za rad:** organizacija zdravstvenog osiguranja; budžet; prodaja usluga i proizvoda; naučnoistraživačka i obrazovna delatnost; promet robe; zakup slobodnog kapaciteta; legati, pokloni, zaveštanja; drugi izvori.

Organi upravljanja i nadzor

Organi ustanove u državnoj svojini: **direktor, upravni odbor, nadzorni odbor**.

PITANJE	ODGOVOR
Ko imenuje i razrešava direktora (osnivač Republika)?	Vlada RS
Ko imenuje direktora ako su osnivači druga lica?	osnivač
Ko imenuje upravni i nadzorni odbor (osnivač RS)?	Vlada RS
Ko donosi statut?	upravni odbor, uz saglasnost osnivača
Ko nadzire rad i poslovanje ustanove?	nadzorni odbor
Ko odgovara za zakonitost rada i poslovanje?	direktor
Ko vrši nadzor nad zakonitošću rada?	ministarstvo nadležno za zdravlje
Ko nadzire primenu zakona i propisanih mera?	zdravstvena inspekcija
Koje dve vrste nadzora postoje?	nad zakonitošću rada i nad stručnim radom

Nadležnosti direktora (dovoljno je znati po grupama):

- **Vođenje:** organizuje i vodi poslovanje, zastupa ustanovu, obezbeđuje zakonitost rada.
- **Akti:** donosi opšti akt o vrsti i stepenu stručne spreme i uslovima radnog mesta.
- **Zapošljavanje:** odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, bira kandidate, zaključuje ugovor o radu, odlučuje o probnom radu, utvrđuje osposobljavanje pripravnika, zaključuje ugovor o volonterskom i dopunskom radu.
- **Raspoređivanje:** trajno i privremeno raspoređivanje, upućivanje i preuzimanje radnika.
- **Radno vreme:** prekovremeni rad, raspored, početak i završetak radnog vremena, odmori i odsustva.
- **Disciplina i prestanak:** utvrđuje disciplinsku odgovornost, odlučuje o udaljavanju radnika, o prestanku radnog odnosa i otkazu.
- **Sud:** izvršava pravosnažnu sudsku odluku donetu radi zaštite prava radnika.

Primarni nivo

- **Dom zdravlja, oblasti rada:** zdravstveno vaspitanje, opšta medicina, zdravstvena zaštita školske dece; zdravstvena zaštita žena i predškolske dece, rendgen dijagnostika; kućno lečenje i nega, hitna medicinska pomoć; polivalentna patronaža; stomatološka zaštita; laboratorijska dijagnostika.
- **Nemedicinski poslovi na primarnom nivou:** služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove; služba za tehničke i druge slične poslove.
- **Apoteka:** može imati galensku laboratoriju; u teritorijalno izdvojenim naseljima organizuje ogranak ili jedinicu za izdavanje gotovih lekova.

Bolnice

- **Opšta bolnica** za jednu opštinu ili sa manje od **50.000** stanovnika objedinjuje četiri oblasti: interna medicina, opšta hirurgija, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo.
- **Stacionarni deo:** odeljenja za standardno, poluintenzivno i intenzivno lečenje i negu.

- **Centralna jedinica intenzivne nege:** u opštoj bolnici u sedištu upravnog okruga ili sa najmanje **500** postelja. Namenjena je i pacijentima sa oštećenjem dva ili više organskih sistema kojima treba mehanička potpora disanju i invazivno hemodinamsko praćenje.
- **Specijalna bolnica:** organizuje jedinice pod uslovima i na način utvrđen za opštu bolnicu.

ODELJENJE	OPŠTA BOLNICA	KLINIKA, INSTITUT, KBC, KLINIČKI CENTAR
Standardno lečenje i nega	24–40 postelja (manje u pedijatriji, akušerstvu, infektivnim)	20–30 postelja
Poluintenzivno	12–16	12–16
Intenzivno	najmanje 6, do 12 za više srodnih oblasti	6–12

Minimalan broj zaposlenih: odeljenje 10, odsek 6, kabinet 3.

Klinika, institut, KBC i klinički centar

USTANOVA	ORGANIZACIONE JEDINICE	POSEBNOST
Klinika	službe, a u njima odeljenja, odseci, kabineti	službe objedinjavaju visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost
Institut	klinike, odnosno službe	klinika objedinjava stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost za jednu granu medicine
Kliničko-bolnički centar	klinike, bolnice, odnosno službe	jedini ima i bolnice kao jedinice
Klinički centar	klinike, centri i službe	centar objedinjava više kliničkih disciplina ili jednu usko specijalizovanu delatnost

Zajedničke medicinske jedinice:

USTANOVA	BROJ JEDINICA	ŠTA JE DRUGAČIJE
Opšta bolnica	8	nema dijagnostičku obradu i prijem, naučnoistraživačku službu ni službu za planiranje i informatiku
Klinika i institut	11	osnovna lista (ispod)
Kliničko-bolnički centar	10 na slajdu	lista se završava naučnoistraživačkom službom
Klinički centar	12	dodata klinička farmakologija; prijem hitnih stanja je urgentni centar

Osnovna lista od 11 jedinica: prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja; specijalističko-konsultativni pregledi; dijagnostička obrada i prijem pacijenata; anestezija sa reanimatologijom; dnevna bolnica; fizikalna medicina i rehabilitacija; laboratorijska, radiološka i patološko-anatomska dijagnostika; bolnička apoteka (farmaceutska

delatnost); snabdevanje krvlju i krvnim produktima; naučnoistraživačka i obrazovna delatnost; organizacija, planiranje, evaluacija i medicinska informatika.

Dnevna bolnica služi za dijalizu, hemoterapiju, hirurške intervencije, opservacije i tretman psihijatrijskih bolesnika.

Zavodi

ZAVOD	JEDINICE	KOJE
Za javno zdravlje	6 centara	promocija zdravlja; analiza, planiranje i organizacija zdravstvene zaštite; informatika i biostatistika; kontrola i prevencija bolesti; higijena i humana ekologija; mikrobiologija
Za transfuziju krvi	4 službe	prikupljanje i testiranje krvi, proizvodnja produkata; laboratorijska dijagnostika; klinička transfuziologija i distribucija krvi; kontrola kvaliteta
Za medicinu rada	4 centra + stacionar	unapređenje medicine rada; dijagnostika i lečenje profesionalnih bolesti; radiološka zaštita; higijena rada i epidemiologija
Za sudsku medicinu	3 službe	obdukcijska i citološka dijagnostika i veštačenje; toksikološka dijagnostika; identifikacija očinstva i bioloških tragova
Za virusologiju, vakcine i serume	4 službe	proizvodnja vakcina; dijagnostički preparati (podloge, antibiogrami); laboratorijska dijagnostika; kontrola kvaliteta
Za antirabičnu zaštitu	4 službe	prevencija besnila i zaraznih bolesti; mikrobiološka dijagnostika; praćenje besnila i zoonoza; kontrola kvaliteta
Za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju	3 službe + stacionar	ambulantno-poliklinička zaštita; dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija; istraživanje i unapređenje kvaliteta
Za biocide i medicinsku ekologiju	3 službe	prevencija zaraznih bolesti; dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija; biocidi i medicinska ekologija
Za zdravstvenu zaštitu studenata	5 jedinica	izabrani lekar (opšta medicina, ginekologija, stomatologija); specijalističko-konsultativna služba; medicinska dijagnostika; unapređenje zdravlja sa savetovalištem za HIV/SIDA i polno prenosive infekcije; stacionar

- **Kako zapamtiti:** centre imaju samo zavod za javno zdravlje i zavod za medicinu rada; svi ostali imaju službe.
- **Stacionar imaju:** medicina rada, govorna patologija i zavod za studente.
- **Zavod za studente:** specijalistička služba ima odeljenja za internu medicinu, oftalmologiju, otorinolaringologiju, psihijatriju i fizikalnu medicinu; može imati ambulante u studentskim domovima.

Lekcija 4: Organizacija zdravstvene delatnosti, radni odnosi

Predavač: Zlatko Ćirić. Cela lekcija je radno pravo: pripravnici i državni službenici, pa prava i obaveze iz Zakona o radu. Najviše se pitaju brojke.

Pripravnik

- **Pripravnik:** lice koje prvi put zasniva radni odnos u svojoj struci i osposobljava se za samostalan rad.
- Izuzetno, pripravnik može biti i lice koje je kod drugog poslodavca radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž. To vreme se **ne uračunava** u staž.
- Radni odnos zasniva na **određeno vreme**, posle sprovedenog **javnog konkursa**.
- Ako opravdano odsustvuje duže od **jednog meseca**, staž se produžava za trajanje odsustva.

OBRAZOVANJE	TRAJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA
Visoko, drugi stepen (master, specijalističke) ili osnovne studije od najmanje 4 godine	1 godina
Visoko, prvi stepen ili studije do 3 godine	9 meseci
Srednje obrazovanje	6 meseci

- **Nastavak rada na neodređeno:** posle staža i položenog državnog (i posebnog stručnog) ispita, ako postoji odgovarajuće radno mesto i ako se raspoređivanje uklapa u kadrovski plan.
- **Stručno osposobljavanje u državnim organima:** pod neposrednim nadzorom mentora. Mentor na kraju dostavlja rukovodiocu izveštaj o rezultatima. Prava i obaveze uređuje ugovor o stručnom osposobljavanju.

Državni službenici

Disciplinski postupak:

- Pokreće ga rukovodilac, na sopstvenu inicijativu ili na predlog pretpostavljenog.
- Pokreće se pismenim zaključkom, na koji žalba nije dopuštena.
- Vodi ga i odlučuje rukovodilac, ili disciplinska komisija od **tri člana** koju on osnuje.
- Održava se usmena rasprava. Službenik se brani sam ili preko zastupnika, a može dostaviti i pismenu odbranu.
- Rasprava može i bez službenika ako postoje važni razlozi, a on je uredno pozvan.

Prestanak radnog odnosa (5 načina): protekom vremena; sporazumom; otkazom; po sili zakona; na drugi način određen zakonom.

- Sporazum je pismeni i određuje dan prestanka. **Službeniku na položaju radni odnos ne može prestati sporazumom.**
- Pismeni otkaz podnosi se najmanje **15 dana** pre dana prestanka.
- Službeniku na položaju, posle preporuke za razrešenje Agencije za borbu protiv korupcije, radni odnos prestaje danom konačnosti rešenja nadležnog organa.

Kadrovski plan:

- Sadrži: broj službenika po radnim mestima i na neodređeno; broj pripravnika čiji se prijem planira; broj službenika na određeno zbog povećanog obima posla.
- Donosi se u roku od **30 dana** od donošenja zakona o budžetu.
- Za organe državne uprave i službe Vlade donosi ga **Vlada**.

Prava i obaveze iz radnog odnosa

- **Individualna prava (7):** odgovarajuća zarada; bezbednost i zdravlje na radu; zdravstvena zaštita; zaštita ličnog integriteta (telesnog i moralnog); dostojanstvo ličnosti i prava u slučaju bolesti, gubitka radne sposobnosti i starosti; materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti; drugi oblici zaštite.
- **Posebna zaštita:** zaposlena žena za vreme trudnoće i porođaja; zaposleni radi nege deteta; zaposleni mlađi od 18 godina; zaposleni invalid.
- **Kolektivna prava (4):** udruživanje; učešće u pregovorima za kolektivni ugovor; mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova; konsultovanje, informisanje i izražavanje stavova.
- **Obaveze zaposlenog (4):** savesno i odgovorno obavlja posao; poštuje organizaciju rada i pravila poslodavca; obaveštava poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču na posao; obaveštava o svakoj opasnosti za život i zdravlje i o materijalnoj šteti.
- **Obaveze poslodavca (5):** isplati zaradu; obezbedi uslove rada i bezbednost; obavesti zaposlenog o uslovima i pravilima rada; obezbedi obavljanje poslova iz ugovora; zatraži mišljenje sindikata (ili predstavnika zaposlenih ako sindikata nema).
- **Zajednička obaveza:** pridržavanje prava i obaveza utvrđenih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Zabrana diskriminacije i zasnivanje radnog odnosa

- Zabranjena je **neposredna i posredna** diskriminacija lica koja traže zaposlenje i zaposlenih (pol, starost, trudnoća, zdravstveno stanje, nacionalnost, vera, bračni status, političko uverenje, članstvo u sindikatu i druga lična svojstva).
- **Zabranjena je u odnosu na (5):** uslove zapošljavanja i izbor kandidata; uslove rada i sva prava iz radnog odnosa; obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje; napredovanje; otkaz ugovora o radu.
- Kandidat dostavlja isprave i dokaze o ispunjenosti uslova.
- **Poslodavac ne sme:** tražiti podatke o porodičnom ili bračnom statusu i planiranju porodice; usloviti posao testom trudnoće (osim kod poslova sa znatnim rizikom za ženu i dete, koji je utvrdio nadležni zdravstveni organ); tražiti unapred potpisanu izjavu o otkazu.
- Pre zaključivanja ugovora poslodavac obaveštava kandidata o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama.
- **Stupanje na rad:** prava i obaveze teku od dana stupanja na rad. Ko ne stupi na rad ugovorenog dana, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim iz opravdanih razloga ili po dogovoru.

Radno vreme

POJAM	PRAVILO
Puno radno vreme	40 časova nedeljno
Mlađi od 18 godina	najviše 35 časova nedeljno
Kraće puno radno vreme opštim aktom	ne kraće od 36 časova nedeljno

POJAM	PRAVILO
Nepuno radno vreme	kraće od punog (ispod 40, odnosno 36; za maloletne ispod 35)
Skraćeno radno vreme	poslovi sa povećanim rizikom; skraćuje se najviše 10 časova nedeljno, na osnovu stručne analize; zaposleni ima sva prava kao sa punim radnim vremenom
Prekovremeni rad	najviše 8 časova nedeljno; ukupno najviše 12 časova dnevno; kod više sile i iznenadnog povećanja obima posla
Radna nedelja i radni dan	po pravilu 5 radnih dana, 8 časova dnevno
Obaveštenje o promeni rasporeda	najmanje 5 dana ranije; izuzetno najmanje 48 časova
Smenski rad	radno vreme se računa kao prosečno nedeljno na mesečnom nivou
Noćni rad	od 22 do 06 časova

- U smenama zaposleni ne radi noću neprekidno duže od jedne radne nedelje; duže samo uz njegovu pismenu saglasnost.
- Ko radi noću najmanje 3 časa svakog radnog dana ili trećinu radnog vremena nedeljno, dobija dnevni posao ako bi mu noćni rad pogoršao zdravlje.
- Pre uvođenja noćnog rada poslodavac traži mišljenje sindikata.
- Raspored radnog vremena utvrđuje poslodavac.

Odmori i odsustva

ODMOR	PRAVILO
U toku dnevnog rada	rad od 4 do 6 časova: 15 minuta; najmanje 6 časova: 30 minuta; najmanje 10 časova: 45 minuta
Dnevni odmor	najmanje 12 časova neprekidno u okviru 24 časa (11 časova za zaposlene iz člana 57)
Nedeljni odmor	najmanje 24 časa neprekidno, po pravilu nedeljom; ako radi tog dana, dobija 24 časa u narednoj nedelji
Godišnji odmor	najmanje 20 radnih dana; pravo se stiče posle mesec dana neprekidnog rada (u neprekidan rad računaju se i bolovanje i plaćeno odsustvo)
Plaćeno odsustvo	do 5 radnih dana godišnje (brak, porođaj supruge, teža bolest člana uže porodice)
Smrt člana uže porodice	5 radnih dana
Dobrovoljno davanje krvi	2 uzastopna dana, računajući dan davanja

- **Odmor u toku rada:** ne koristi se na početku ni na kraju radnog vremena; uračunava se u radno vreme; raspored određuje poslodavac.

- **Godišnji odmor:** zaposleni ga se ne može odreći niti se može zameniti novcem, osim kod prestanka radnog odnosa. Minimum od 20 dana uvećava se po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva i stručne spreme. Radna nedelja računa se kao 5 radnih dana.
- U godišnji odmor se ne uračunavaju praznici, plaćeno odsustvo i bolovanje. Ko se razboli na odmoru, nastavlja odmor posle bolovanja.
- **Srazmerni deo:** dvanaestina godišnjeg odmora za svaki mesec rada u godini zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.
- **Članovi uže porodice:** bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj.

Zarada, udaljenje, sindikat

- **Zarada:** garantuje se jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti. Odluka ili sporazum suprotan tome je ništav, a zaposleni ima pravo na naknadu štete.
- **Rad jednake vrednosti:** isti stepen stručne spreme, jednak radni doprinos, jednaka odgovornost.
- **Privremeno udaljenje sa rada:** ako je započeto krivično gonjenje za delo učinjeno na radu ili u vezi s radom (do pravnosnažnog okončanja); ili ako je povreda radne obaveze takva da zaposleni ne može da nastavi rad.
- **Naknada za vreme udaljenja:** jedna četvrtina osnovne zarade, a jedna trećina ako izdržava porodicu. Isplaćuje je poslodavac.
- **Sindikat:** sloboda organizovanja jamči se bez odobrenja, uz upis u registar. Pristupa se potpisivanjem pristupnice.
- Sindikat ima pravo da bude obavešten o ekonomskim i radno-socijalnim pitanjima. Poslodavac mu obezbeđuje tehničko-prostorne uslove i pristup podacima; uslovi se utvrđuju kolektivnim ugovorom ili sporazumom.

Lekcija 5: Upravljanje

Predavač: Zlatko Ćirić. Tri teme: obavezno zdravstveno osiguranje, pravna sredstva u upravnom postupku (prigovor i žalba) i kancelarijsko poslovanje.

Obavezno zdravstveno osiguranje

- **Definicija:** osiguranje kojim se zaposlenima i drugim građanima obuhvaćenim obaveznim osiguranjem obezbeđuju **pravo na zdravstvenu zaštitu** i **pravo na novčane naknade**.
- **Gde se sprovodi:** u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.
- **Sredstva:** uplata doprinosa i drugi izvori u skladu sa zakonom.
- **Obuhvata:** osiguranje za slučaj bolesti i povrede van rada; osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Prigovor

Pravo na prigovor postoji ako ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku.

RAZLOG ZA PRIGOVOR	ROK
Neispunjenje obaveze iz upravnog ugovora	6 meseci od propuštanja organa
Upravna radnja (preduzeta ili propuštena)	15 dana
Način pružanja javnih usluga (ne pruža se uredno i kvalitetno)	15 dana

- Prigovor se izjavljuje **rukovodiocu organa** na čije se postupanje odnosi, i on o njemu odlučuje.
- Rukovodilac utvrđuje činjenično stanje i ispituje zakonitost i pravilnost postupanja organa.

Žalba

- Stranka ima pravo na žalbu protiv rešenja **prvostepenog organa**, ako žalba nije zakonom isključena.
- Žalba je **uvek isključena protiv rešenja Vlade**.
- Nadležnost za odlučivanje o žalbi ne uređuje Zakon o opštem upravnom postupku, već zakoni u pojedinim upravnim oblastima.
- **Ćutanje administracije:** žalba je moguća i kad rešenje nije izdato u zakonskom roku.
- Izuzetak: nema žalbe ako posebni zakon kaže da se neizdavanje rešenja u roku smatra usvajanjem zahteva.

Kancelarijsko poslovanje

- **Šta je:** raznovrsni administrativni poslovi koji traže dobru organizaciju i stručnost, a omogućavaju uredno obavljanje osnovnih i sporednih poslova organa.
- **Osnovni zadatak:** minimum pravila za efikasno i uredno poslovanje; proces planiranja, koordinacije, praćenja i kontrole stručnih radnji u obradi predmeta i dokumentacije.

NAČELO	SUŠTINA
Tačnost	organ deluje na osnovu pravilno i potpuno utvrđenih činjenica (evidencija akata, prijem i otprema pošte, razvođenje predmeta)
Ekspeditivnost	blagovremeno ostvarivanje i zaštita prava stranaka; u suprotnom nastaje ćutanje administracije
Jednostavnost i preglednost	poslovi se obavljaju jednostavno i pregledno
Jednoobraznost	rad po utvrđenim i propisanim pravilima poznatim svim učesnicima
Ekonomičnost	bez odugovlačenja i sa što manje troškova za stranku
Racionalnost	što veća ušteda vremena i materijala (savremena sredstva komunikacije, standardni obrasci)

Pojmovi kancelarijskog poslovanja

POJAM	DEFINICIJA
Podnesak	svaki zahtev, obrazac, predlog, prijava, molba, žalba, prigovor kojim se stranke obraćaju organima
Akt	pisani sastav kojim se pokreće, dopunjuje, menja, prekida ili završava službena radnja
Prilog	pisani sastav (dokument, tabela, grafikon, crtež) ili fizički predmet uz akt, radi dopune, objašnjenja ili dokazivanja
Predmet	skup svih podnesaka, akata i priloga o istom pitanju ili zadatku
Dosije	skup više predmeta o istoj materiji ili istom licu
Fascikla	skup više predmeta ili dosijea koji se posle završenog postupka čuvaju u istom omotu
Registraturski materijal	predmeti, akti, snimci, zapisi, knjige i kartoteke primljeni i nastali u radu organa
Arhivska građa	izvorni i reprodukovani dokumentarni materijal od posebnog značaja za istoriju i kulturu, bez obzira kada je nastao
Prijemna kancelarija	jedinica koja informiše stranke i pomaže im oko podnesaka, prima podneske, obaveštava o stanju rešavanja zahteva

Redosled od manjeg ka većem: podnesak, akt i prilog čine predmet; više predmeta čini dosije; više predmeta ili dosijea čuva se u fascikli.

Vođenje evidencije putem automatske obrade podataka (6 poslova): formiranje i održavanje datoteka; rad sa strankama; izrada dnevnih izveštaja; periodični izveštaji; dinamika primljenih i arhiviranih predmeta; statistička obrada podataka.

Pečati i štambilji: državni pečat

- Okruglog je oblika, prečnika **60 mm**.
- U sredini je veliki grb Republike Srbije.
- U krugu oko grba je naziv države: „REPUBLIKA" iznad grba, „SRBIJA" ispod grba.

Lekcija 6: Osnovni principi organizacije zdravstvene službe

Predavač: dr med. Miloš Potkrajac. Izvor: video predavanje uz lekciju 1 (slajdovi „Organizacija zdravstvene zaštite"). Ovo predavanje ima druge slajdove od prezentacije iz lekcije 1: objašnjava nivoe zaštite, vanbolničke ustanove i bolnice.

Zdravstvena zaštita i modeli organizacije

- **Zdravstvena zaštita:** kombinacija lične i kolektivne odgovornosti za zdravlje i javne (državne) odgovornosti za javno-zdravstvene funkcije. Uključuje državni i privatni sektor, dobrotvorne i humanitarne organizacije.
- **Osnovne komponente sistema:** resursi (kadrovski i materijalni), finansiranje, organizacija, administracija, upravljanje i pružanje zdravstvenih usluga.
- **Ne postoji nijedan najbolji način** za organizovanje zdravstvene zaštite i službe.
- Razlike među zemljama su u **strukturi, organizovanju i finansiranju**, a rezultat su istorijskih, sociokulturnih, ekonomskih i političkih faktora.
- **Nivoi zaštite dele se na osnovu:** veličine populacije, karakteristika oboljenja i stanja, organizacionih karakteristika.

Nivoi zdravstvene zaštite

NIVO	SUŠTINA	KO PRUŽA ZAŠTITU
Samozaštita	neprofesionalni, laički nivo, ostvaruje se u porodici; najčešće 1 do 2, najviše 10 osoba	članovi porodice: očuvanje zdravlja, prevencija, samodijagnoza, samolečenje, samomedikacija, nega obolelih i slabih
Primarna	prvi profesionalni nivo i prvi kontakt, kad se pacijent prvi put javi sa simptomima	tim: lekar, medicinska sestra, babica, patronažna sestra, socijalni radnik, fizioterapeut
Sekundarna	specijalistička služba za kompleksnija stanja od onih koje rešava lekar na primarnom nivou	„opšti specijalisti" u opštim bolnicama: opšti hirurzi, internisti, ginekolozi, psihijatri
Tercijarna	visoko specijalizovan ili subspecijalistički nivo; region, 500.000 do 5 miliona stanovnika	plastični hirurzi, neurohirurzi, kardiohirurzi; ustanove su i škole za kadrove (univerzitetske bolnice, klinike)

Zdravstvena služba i vanbolničke ustanove

- **Zdravstvena služba:** permanentan i širom zemlje raspoređen sistem uspostavljenih institucija sa višestrukim ciljevima. Pruža preventivne i kurativne usluge.
- **Vanbolničke ustanove:** pružaju usluge kod urgentnih i akutnih bolesti koje traže hitnu intervenciju i kod hroničnih bolesti koje traže praćenje.
- Razvile su se da se **rasterete bolnice** i lečenje obavlja u jeftinijim uslovima. Prve su bila ambulantno-poliklinička odeljenja bolnica.
- **Hitna služba:** za akutno obolele i povređene. Koristi se i kao jednostavan ulaz u bolnicu (bez uputa). Samo **5%** slučajeva je zaista hitno, **45%** urgentno, a **50%** ni jedno ni drugo.

- Kod nas hitnu pomoć na mestu nesreće pružaju posebno organizovane službe hitne pomoći, osim u masovnim katastrofama.
- **Poliklinička (ambulantna) služba:** prati bolesnika posle hospitalizacije; može biti i referalni nivo sa primarne zaštite (pregled, dijagnostika, odluka o prijemu u bolnicu). Primer: Poliklinika Kliničkog centra Srbije.

Primarna zdravstvena zaštita (PZZ)

- Zaštita prvog kontakta: mesto gde se tretiraju svakodnevni problemi i preduzimaju preventivne mere. Institucije PZZ su **vanbolničke** ustanove.
- **Organizacioni oblici:** grupna praksa (zdravstveni centri, domovi zdravlja) i individualna praksa.
- **Mesto pružanja:** ordinacija, kuća obolelog, škola, radno mesto.
- **Glavna kadrovska komponenta:** doktor porodične medicine.
- **Alma Ata (1978):** lekar pruža zaštitu stanovništvu bez obzira na starost, dijagnozu, sistem organa i kategoriju stanovništva.

Zadaci doma zdravlja:

1. Prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva, higijenske prilike i uslove života.
2. Sprovodi mere za zdravstvenu zaštitu žena, trudnica, odojčadi, predškolske dece, omladine i radnika.
3. Sprovodi mere sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja zaraznih i drugih masovnih oboljenja i povreda.
4. Obavlja patronažnu službu.
5. Organizuje i radi na zdravstvenom vaspitanju.
6. Leči i sprovodi rehabilitaciju obolelih i povređenih, u ustanovi i u stanu bolesnika.
7. Sprovodi mere sprečavanja oboljenja usta i zuba i vrši lečenje.
8. Obavlja dezinfekciju i dezinsekciju.

Bolnice

- **Poreklo:** prve ustanove za smeštaj i lečenje obolelih pominju se u 3. veku p. n. e. Preteče bolnica u Evropi nastaju u hramovima antičke Grčke (Asklepijevi hramovi) i Rima, a sa hrišćanstvom u crkvama i manastirima.
- **Naziv:** većina evropskih naziva potiče od latinskog *hospitium* (gostoljublje). Naš naziv potiče od slovenskog korena „bol".
- Naziv bolnica prvi put se pominje u **Hilandarskom tipiku Svetog Save** (XIII vek). Njime je uređeno osnivanje najstarije srpske bolnice, uz manastir Hilandar, **1191. godine**.
- **Definicija (Komitet eksperata SZO, 1960-te):** stacionarna ustanova koja obezbeđuje kratkotrajnu i dugotrajnu medicinsku zaštitu: posmatranje, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione usluge, kao i usluge porodiljama i novorođenčadi.
- Bolnice mogu, ali **ne moraju**, obezbeđivati ambulantne usluge.

VLASNIŠTVO	KO JE VLASNIK ILI OSNIVAČ
Društvene	lokalna zajednica; u većini sistema najbrojnije
Državne	država, za određena oboljenja ili grupe; finansira ih iz budžeta

VLASNIŠTVO	KO JE VLASNIK ILI OSNIVAČ
Karitativne	crkva ili filantropske organizacije
Privatne	pojedinci ili grupe ljudi

- **Veličina:** od desetak postelja do preko hiljadu. Minimum je **6 postelja** po Američkom udruženju bolnica, a **kod nas 10**.
- **Po veličini:** lokalne (opštinske), intermedijarne i regionalne (nacionalne) bolnice.
- Veće bolnice daju širi spektar usluga, ali imaju veće troškove; sa veličinom raste otuđenje i nezadovoljstvo zaposlenih.
- **Opšte bolnice:** dostupne svim uzrasnim grupama, pružaju akutnu bolničku zaštitu na određenoj teritoriji. Uglavnom su lokalne ili intermedijarne (međuopštinske). Ranije se preporučivalo **400 do 600 postelja**; danas je broj postelja sve manje pouzdan pokazatelj, jer se lečenje skraćuje i raste značaj dnevne bolnice.
- **Neprofitne opšte bolnice:** obezbeđuju više od polovine postelja, rešavaju oko **dve trećine** zahteva za bolničkim lečenjem (opšta hirurgija, interna medicina, akušerstvo) i više od polovine vanbolničkih specijalističkih pregleda. Zato su „kičma" svakog sistema zdravstvene zaštite.

Lekcija 7: Organizacija zdravstvene delatnosti, ustanove i sestrinski menadžment

Predavač: Ivana Jovčić, spec. strukovna medicinska sestra. Izvor: video predavanje uz lekciju Menadžment (dokument od 64 strane). Prvi deo je o ustanovama po nivoima, osiguranju i dokumentaciji; drugi deo o liderstvu, motivaciji i organizaciji sestrinske službe. Zadaci doma zdravlja i opšte bolnice isti su kao u lekciji 6, pa se ovde ne ponavljaju.

Osnivanje ustanova i Plan mreže

- **Osnivač zdravstvene ustanove:** Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava, pravno ili fizičko lice. Sredstva mogu biti u državnoj ili privatnoj svojini.
- Ustanove u državnoj svojini osnivaju se u skladu sa **Planom mreže zdravstvenih ustanova**.
- **Plan mreže utvrđuje se na osnovu:** plana razvoja; zdravstvenog stanja stanovništva; broja i starosne strukture stanovništva; postojećeg broja, kapaciteta i rasporeda ustanova; stepena urbanizacije, razvijenosti i saobraćajne povezanosti; jednake dostupnosti zdravstvene zaštite; potrebnog obima određenog nivoa delatnosti; ekonomskih mogućnosti Republike.
- Sistem zdravstva organizovan je u **tri nivoa**: primarni, sekundarni, tercijarni.

Primarni nivo

- **Organizacione jedinice po funkcionalnom principu:** služba, odeljenje, odsek. **Po teritorijalnom principu:** ogranak, zdravstvena stanica, zdravstvena ambulanta.
- **Najmanji broj zaposlenih:** služba 10, odeljenje 5, odsek 3. (Pazi: u lekciji 3, za kliniku, važi odeljenje 10, odsek 6, kabinet 3.)
- **Dom zdravlja može obrazovati službe za (15):** zdravstvenu zaštitu dece; školske dece; žena; odraslih stanovnika; radnika; hitnu medicinsku pomoć; kućno lečenje i negu; polivalentnu patronažu; stomatologiju; radiološku dijagnostiku; laboratorijsku dijagnostiku; farmaceutsku delatnost; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; stacionar; porodilište.
- **U domu zdravlja obezbeđuje se i:** stomatološka zaštita; zaštita zaposlenih (medicina rada); fizikalna medicina i sanitetski prevoz (ako nisu organizovani u drugoj ustanovi); farmaceutska delatnost.
- **Zdravstvena ambulanta:** najmanje opšta medicina. **Zdravstvena stanica:** najmanje hitna medicinska pomoć, opšta medicina i zdravstvena zaštita dece.
- **Apoteka:** farmaceutska delatnost na primarnom nivou: promocija zdravlja, promet lekova na malo, praćenje dostignuća farmakoterapije i informisanje, saveti pacijentima, izrada magistralnih lekova. Može imati galensku laboratoriju i ogranak.
- **Zavodi na primarnom nivou:** za zdravstvenu zaštitu studenata; radnika; hitnu medicinsku pomoć; gerontologiju; stomatologiju; plućne bolesti i TBC; kožno-venerične bolesti.

Sekundarni i tercijarni nivo

USTANOVA	ŠTA OBAVLJA	POSEBNOST
Opšta bolnica	zaštita lica svih uzrasta; najmanje: prijem hitnih stanja; interna, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo, opšta hirurgija; laboratorija i RTG; anestezija sa reanimacijom; ambulanta za rehabilitaciju; bolnička apoteka	sekundarni nivo

USTANOVA	ŠTA OBAVLJA	POSEBNOST
Specijalna bolnica	specijalističko-konsultativna i stacionarna delatnost za određene bolesti ili grupe stanovnika	sekundarni nivo
Klinika	visokospecijalizovana delatnost iz jedne grane medicine, obrazovna i naučnoistraživačka	samo u sedištu univerziteta sa fakultetom zdravstvene struke
Institut	visokospecijalizovana stacionarna i konsultativna, ili samo konsultativna delatnost	mora ispuniti i uslove zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti
Kliničko-bolnički centar	visokospecijalizovana delatnost iz jedne ili više grana medicine	uslovi za opštu bolnicu i za kliniku
Klinički centar	objedinjuje **tri ili više klinika**: zdravstvena, obrazovno-nastavna i naučnoistraživačka delatnost	ako u sedištu nema opšte bolnice, obavlja i njenu delatnost

- Opšta i specijalna bolnica moraju obezbediti: sanitetski prevoz na tercijarni nivo, snabdevanje krvlju i službu za patološku anatomiju.
- **Specijalne bolnice:** preteče su samostalna porodilišta (VII vek, Aleksandrija), leprozorijumi, bolnice za duševno obolele, tuberkulozu i venerične bolesti. Broj bolnica za tuberkulozu i psihijatriju opada, a raste potreba za gerijatrijskim.
- Ustanove tercijarnog nivoa na Zapadu zovu se univerzitetske bolnice. Naziv klinika potiče od grčkog *kline* (postelja).

Zavod za javno zdravlje i zavodi na više nivoa

- **Zavod za javno zdravlje:** socijalno-medicinska, higijensko-epidemiološka i mikrobiološka delatnost.
- **Delatnost obuhvata najmanje:** socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstvene službe, zdravstveno vaspitanje, statistiku, informatiku i ekonomiku zdravstva; epidemiologiju sa mikrobiologijom, parazitologijom i virusologijom; higijenu sa zaštitom životne sredine; dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.
- **Poslovi:** prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva; proučava zdravstvene probleme i rizike; predlaže elemente zdravstvene politike; informiše i obučava stanovništvo; procenjuje efikasnost, dostupnost i kvalitet zaštite; planira stručno usavršavanje; podstiče razvoj informacionog sistema; sprovodi istraživanja; sarađuje sa zajednicom.
- Koordinira rad ustanova iz Plana mreže i ispituje namirnice, vodu, vazduh i predmete opšte upotrebe.
- **Ostali zavodi na više nivoa:** za transfuziju krvi; medicinu rada; sudsku medicinu; virusologiju, vakcine i serume; antirabičnu zaštitu; psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju.

Zdravstveno osiguranje i participacija

- **Zdravstveno osiguranje:** sistem pokrivanja troškova zaštite unapred, preko **doprinosa (Bizmarkov sistem)** ili **poreza (Beveridžov sistem)**.
- Obavezno osiguranje pokriva **osnovni paket** usluga. Dobrovoljno zaključuju oni koji nisu obavezno osigurani, za osnovni ili dodatni paket.

- **Najvažniji princip:** solidarnost. Osiguranik dobija ispravu (zdravstvena knjižica, kartica).
- **Participacija** je jedino što osiguranik plaća. Ustanova izdaje račun koji je propisao RFZO. Za neosnovano naplaćenu participaciju traži se refundacija u matičnoj filijali.
- **Oslobođeni participacije:** ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa i trajno nepokretna lica, lica sa naknadom za tuđu pomoć i negu, dobrovoljni davaoci krvi.
- **Davaoci krvi:** 10 i više davanja, trajno; manje od 10, **12 meseci** posle svakog davanja. Ne važi za lekove sa Liste lekova, pomagala i implantate.
- Oslobođene su i socijalno ugrožene kategorije čije osiguranje plaća budžet: nezaposleni, izbegla i raseljena lica, stariji od 65 bez penzije, lica romske nacionalnosti.

Medicinska dokumentacija

Osnovna medicinska dokumentacija (11): zdravstveni karton; stomatološki karton; karton obavezne imunizacije; protokol; istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja; matična knjiga lica smeštenih u stacionarnu ustanovu; temperaturno-terapijsko-dijetetska lista; list anestezije; otpusna lista sa epikrizom; list za novorođenče; knjiga evidencije.

Liderstvo i stilovi rukovođenja

- **Četiri elementa liderstva:** podrazumeva druge ljude; podrazumeva nejednaku raspodelu moći; sposobnost korišćenja različitih oblika uticaja; etika.
- **Dva izvora moći:** organizaciona (moć nagrađivanja, moć prisile, legitimna moć) i lična (ekspertska, referentna).
- **Osobine lidera (11):** inteligencija, čestitost, nepristrasnost, odlučnost, sposobnost prosuđivanja, prijatnost, stručno znanje, zdravlje, sposobnost saradnje, samopouzdanje, dominantnost.

STIL	KONTROLA I MOTIVACIJA	KOMUNIKACIJA I ODLUKE
Autoritativni	stroga kontrola; motivacija prinudom; upravlja se komandama	komunikacija opada; odluke ne uključuju ostale; naglasak na „ja" i „ti"; kritičnost je kažnjiva
Demokratski	manja spoljna kontrola; ekonomsko nagrađivanje; sugestije i uputstva	komunikacija u svim pravcima; odluke uključuju ostale; naglasak na „mi"; kritika je konstruktivna
Princip „nemešanja"	popustljiv, malo ili nimalo kontrole; motiviše podrškom na zahtev	naglasak na grupu; ne kritikuje

- **Stil usmeren na zadatak:** lider određuje šta, ko, kako, kada i gde; postavlja ciljeve, organizuje, određuje rokove i troškove, nadgleda i kontroliše. Naglasak je na **produktivnosti**.
- **Stil usmeren ka ljudima:** podrška, komuniciranje, poboljšanje odnosa, aktivno slušanje, povratno informisanje. Naglasak je na **međuljudskim odnosima**.
- **Rezolucija SZO iz 1992:** zemlje treba da ojačaju menadžerske i liderske sposobnosti sestara i babica.
- **Važne oblasti procesa menadžmenta (5):** mobilisanje, osposobljavanje, definisanje, merenje, komunikacija.

Odlučivanje i motivacija

- **Model procesa zdravstvene nege (PZN)** daje teorijski sistem za rešavanje problema i odlučivanje. Njegova snaga je **mehanizam povratnih informacija**.
- **Principi odlučivanja (6):** jasno definisati cilj ili problem; prikupiti informacije; smisliti dosta alternativa; razmišljati logično i analizirati rešenja; odabrati i raditi odlučno; primeniti, pratiti i evaluirati.
- **Jačina motivacije zavisi od:** jasnoće cilja; veličine interesa da se cilj ostvari; uslova za ostvarenje; odnosa uloženog truda i vrednosti; procene verovatnoće da će cilj biti ostvaren.
- **Pet faza motivacije:** suočavanje sa zadatkom i prihvatanje cilja; napor da se cilj postigne; evaluacija postignutog; analiza razloga uspeha ili neuspeha; sagledavanje uslova uspeha ili neuspeha.
- **Proces motivacije:** nezadovoljena potreba → tenzija → akcija prema cilju → postignuti cilj → zadovoljena potreba → smanjena tenzija.
- **Sestra lider** se fokusira na individualne potrebe radnika; individualni ciljevi ne smeju biti u sukobu sa ciljevima ustanove.
- **Najbolji način motivisanja sestara:** informisanje, motivisanje, profesionalni razvoj, adekvatne kritike i pohvale.
- **Moć iz funkcije koristi se adekvatno:** biti srdačan i iskren, jasan u izlaganju, obrazložiti zahtev, opomenuti pre kazne, kažnjavati dosledno i diskretno, tretirati podređene pravedno.

Organizacija sestrinske službe

- **Za planiranje kadrova sestre treba da imaju:** profesionalnu autonomiju u praksi; sestrinsku kontrolu u radnoj sredini; efikasnu komunikaciju sa lekarima i rukovodstvom; da su vrednovane i motivisane.
- **Planiranje kadrova zasniva se na:** razvoju ustanove i zdravstvene nege; sadašnjem stanju i kvalifikacionoj strukturi; analizi budućih potreba; broju sestara na školovanju; broju sestara pred unapređenjem, odlaskom ili penzijom; stanju obrazovnih institucija; broju sestara na tržištu rada.
- **Faktori organizacione strukture:** priroda posla, tehnologija, ljudi i kultura.
- **Za efikasnu organizaciju neophodni su:** podela rada, organizaciona struktura, koordinacija.
- Centralizovana kontrola je zastarela; **decentralizacija** je glavna snaga dobre organizacije sestrinske službe.
- **Komponente organizacione strukture:** organizaciona šema; podela rada (sistematizacija); decentralizacija (distribucija autoriteta); koordinacija. Proističu iz diferenciranja i integracije.
- **Organizaciona šema** simbolično prikazuje strukturu. Zavisi od: vrednovanja sestrinstva u ustanovi; samostalnosti sestara u radu; spremnosti na samostalno odlučivanje; sposobnosti da se izbore za promene.
- **Vrste organizacionih struktura (4):** linearna, matrična, ravna, ad hok.
- **Nivoi menadžera sestara (3):** centralni nivo (glavna sestra ustanove), srednji nivo, prvi nivo.
- **Raspon kontrole zavisi od:** sposobnosti sestre menadžera; zrelosti zaposlenih sestara; kompleksnosti zadataka; udaljenosti (lokacije); nivoa organizacije.
- **Savremeni modeli temelje se na tri elementa:** profesionalna autonomija u praksi; sestrinska kontrola nad radnom sredinom; efikasna komunikacija između sestara, lekara i rukovodstva.
- **Delegiranje:** oblik decentralizacije u kojem se deo autoriteta i odgovornosti prenosi na niže delove hijerarhije.

Brojke i rokovi napamet

Ovo su sve brojke iz svih sedam lekcija na jednom mestu; ponovi ih dan pred ispit.

Lekcije 1 i 2

ŠTA	BROJKA
Komponente sistema zdravstvene zaštite	5
Oblici zdravstvene ustanove	9
Komore	5
Izvori finansiranja	4
Modeli sistema	3
Samozaštita	1–10
Opšta medicina	2.000–50.000
Specijalistička zaštita	100.000–500.000
Subspecijalistička zaštita	500.000–5.000.000
Veštine za zdrav i srećan život (SZO)	5
Elementi komunikacionog procesa	5
Faze razvoja tima	4
Timske uloge (Belbin, 1993)	9
Karakteristike uspešnog tima	7
Prepreke efikasnosti	8
Neželjeni događaji zbog loše komunikacije (JCAHO, 2004)	više od 60%
Govor tela / kako kažemo / šta kažemo	55% / 38% / 7%

Lekcija 3

ŠTA	BROJKA
Definicija zdravlja SZO	1948
Komponente, ciljevi, funkcije menadžmenta, uloge menadžera	5, 3, 4, 3
Organi ustanove	3

ŠTA	BROJKA
Opšta bolnica za jednu opštinu	manje od 50.000 stanovnika, 4 oblasti
Centralna intenzivna jedinica	bolnica sa najmanje 500 postelja ili sedište okruga
Standardno odeljenje	24–40 (opšta bolnica), 20–30 (klinika i ostali)
Poluintenzivno odeljenje	12–16
Intenzivno odeljenje	najmanje 6, do 12
Odeljenje / odsek / kabinet	10 / 6 / 3 zaposlenih
Zajedničke jedinice	opšta bolnica 8, klinika i institut 11, klinički centar 12
Zavod za javno zdravlje	6 centara
Zavod za medicinu rada	4 centra + stacionar
Transfuzija, virusologija, antirabična	po 4 službe
Sudska medicina, govorna patologija, biocidi	po 3 službe

Lekcije 4 i 5

ŠTA	BROJKA
Pripravnički staž	1 godina / 9 meseci / 6 meseci
Disciplinska komisija	3 člana
Otkaz državnog službenika	najmanje 15 dana ranije
Kadrovski plan	30 dana od zakona o budžetu
Puno radno vreme	40 časova (min. 36; mlađi od 18: 35)
Skraćenje radnog vremena	najviše 10 časova nedeljno
Prekovremeni rad	najviše 8 časova nedeljno, 12 časova dnevno ukupno
Promena rasporeda	5 dana ranije, izuzetno 48 časova
Noćni rad	22–06
Odmor u toku rada	15 / 30 / 45 minuta
Dnevni i nedeljni odmor	12 časova (11) i 24 časa
Godišnji odmor	najmanje 20 radnih dana, posle mesec dana rada

ŠTA	BROJKA
Plaćeno odsustvo	do 5 dana; smrt člana porodice 5 dana; davanje krvi 2 dana
Naknada kod udaljenja	1/4 zarade, 1/3 ako izdržava porodicu
Prigovor	6 meseci (upravni ugovor), 15 dana (radnja, javna usluga)
Načela kancelarijskog poslovanja	6
Državni pečat	prečnik 60 mm

Lekcije 6 i 7

ŠTA	BROJKA
Samozaštita	1 do 2, najviše 10 osoba
Hitan prijem: hitno / urgentno / ni jedno	5% / 45% / 50%
Alma Ata, konferencija o PZZ	1978
Najstarija srpska bolnica (Hilandar)	1191
Definicija bolnice, SZO	1960-te
Minimum postelja u bolnici	6 (Američko udruženje), 10 kod nas
Ranija preporuka za opšte bolnice	400 do 600 postelja
Neprofitne opšte bolnice	više od polovine postelja, oko 2/3 bolničkog lečenja
Primarni nivo: služba / odeljenje / odsek	10 / 5 / 3 zaposlenih
Službe doma zdravlja	15
Klinički centar	3 ili više klinika
Davaoci krvi i participacija	10+ davanja trajno; inače 12 meseci
Osnovna medicinska dokumentacija	11
Elementi liderstva / osobine lidera	4 / 11
Rezolucija SZO o sestrinstvu	1992
Principi odlučivanja / faze motivacije	6 / 5
Vrste organizacionih struktura / nivoi glavnih sestara	4 / 3